

Céphalée aiguë non traumatique

39

1. Introduction^{1,2}

- Il s'agit d'un motif de consultation fréquent en médecine de premier recours ambulatoire (environ 4% des consultations) et dans les services d'urgences hospitalières (environ 2% des consultations au Service des Urgences du CHUV à Lausanne).

2. Définition | Classification³⁻⁷

- Céphalées **primaires** (environ **95%** de toutes les céphalées) (*cf. Annexe* en fin de chapitre):
 - céphalée de tension: la plus fréquente des céphalées: prévalence globale de 60 à 80%
 - migraine sans aura: 75% des crises migraineuses
 - migraine avec aura
 - céphalées trigémino-autonomiques, par exemple, céphalée en grappe (*cluster headache*): < 1% des céphalées primaires
 - autres (céphalée d'effort, etc.)
- Céphalées **secondaires** (environ **5%** de toutes les céphalées):
 - méningo-encéphalite
 - dissection carotidienne ou vertébrale
 - thrombose sino-veineuse cérébrale
 - hémorragie sous-arachnoïdienne
 - masse intracrânienne

- hyper- ou hypotension intracrânienne
- artérite giganto-cellulaire de Horton
- autres : apoplexie pituitaire, pré-éclampsie, origine ORL, ophtalmologique (p. ex. glaucome, uvéite), toxique (p. ex. CO, médicaments), sevrage médicamenteux (p. ex. œstrogènes, opioïdes) ou de caféine, etc.

3. Drapeaux rouges¹⁻¹²

Critères d'urgence

- Céphalée en coup de tonnerre (pic de douleur atteint en ≤ 1 min.) ou explosive
- Céphalée décrite spontanément comme «la pire»
- Symptômes neurologiques récents inhabituels
- Céphalée isolée et état fébrile (EF) sans évidence pour un foyer infectieux ou un syndrome grippal en période épidémique
- Hypertension artérielle (HTA) $\geq 180/120$ ou signes d'hypertension maligne (hémorragie rétinienne, exsudat ou œdème papillaire au fond d'œil, atteinte rénale ou symptômes neurologiques, douleur rétrosternale, insuffisance cardiaque gauche)
- Présence d'une syncope ou de vomissements (hors migraine)
- Traumatisme crânien ou de la nuque récent ou manipulation cervicale
- Grossesse et post-partum
- Anticoagulation
- Suspicion de glaucome
- Rash et/ou méningisme

➔ Une **prise en charge en urgence** est recommandée.

N.B. Tout patient avec céphalées aiguës associées à une **raideur de nuque** et/ou une altération de l'**état de conscience** doit être adressé à un service d'urgence approprié (disponibilité 24h/24 d'un neurologue, voire d'un neurochirurgien, d'un scanner et/ou IRM et d'un service de surveillance continue). Toutefois, ce transfert ne devrait en aucun cas retarder la prise de mesures urgentes, tout particulièrement l'administration d'antibiotiques si l'on suspecte une **méningite**.

39. Céphalée aiguë non traumatique

Situations à risque

- Céphalée nouvelle, différente ou d'aggravation progressive: localisation, durée, évolution, qualité, intensité ou mode d'apparition
 - Céphalée déclenchée ou aggravée par le Valsalva, l'effort (exercice, activité sexuelle) ou les changements de position
 - Douleurs des ceintures et/ou claudication de la mâchoire et/ou myalgie et/ou sensibilité temporale
 - Céphalée inaugurale au-delà de l'âge de 50 ans
 - Perte pondérale, fatigue, sudations
 - Autre anomalie à l'examen neurologique
 - VIH, immunosuppression, cancer
 - Suspicion de céphalées médicamenteuses ou d'intoxication au CO
- ➔ Des investigations ambulatoires, une **consultation neurologique** ou une hospitalisation électorive en prévision d'examens complémentaires sont en général nécessaires. Le degré d'urgence dépend de la situation clinique.

N.B. La règle d'Ottawa peut être utilisée pour exclure une hémorragie sous-arachnoïdienne chez les patients de plus de 15 ans consultant dans un **centre d'urgence** pour une **céphalée sévère** non traumatique ayant atteint son intensité maximale **en moins d'une heure**. Ne pas appliquer cette règle en cas de céphalée récurrente (≥ 3 épisodes en ≥ 6 mois), en présence d'un déficit neurologique ou lors d'antécédents de: anévrisme, hémorragie sous-arachnoïdienne, tumeur cérébrale. Des investigations s'imposent en présence d'au moins un critère positif (tableau 1). Cette règle n'a pas été validée en médecine de premier recours et risque de surestimer dans ce cas le risque d'hémorragie sous-arachnoïdienne. Elle ne dispense donc pas le clinicien d'une appréciation circonstanciée de la situation.

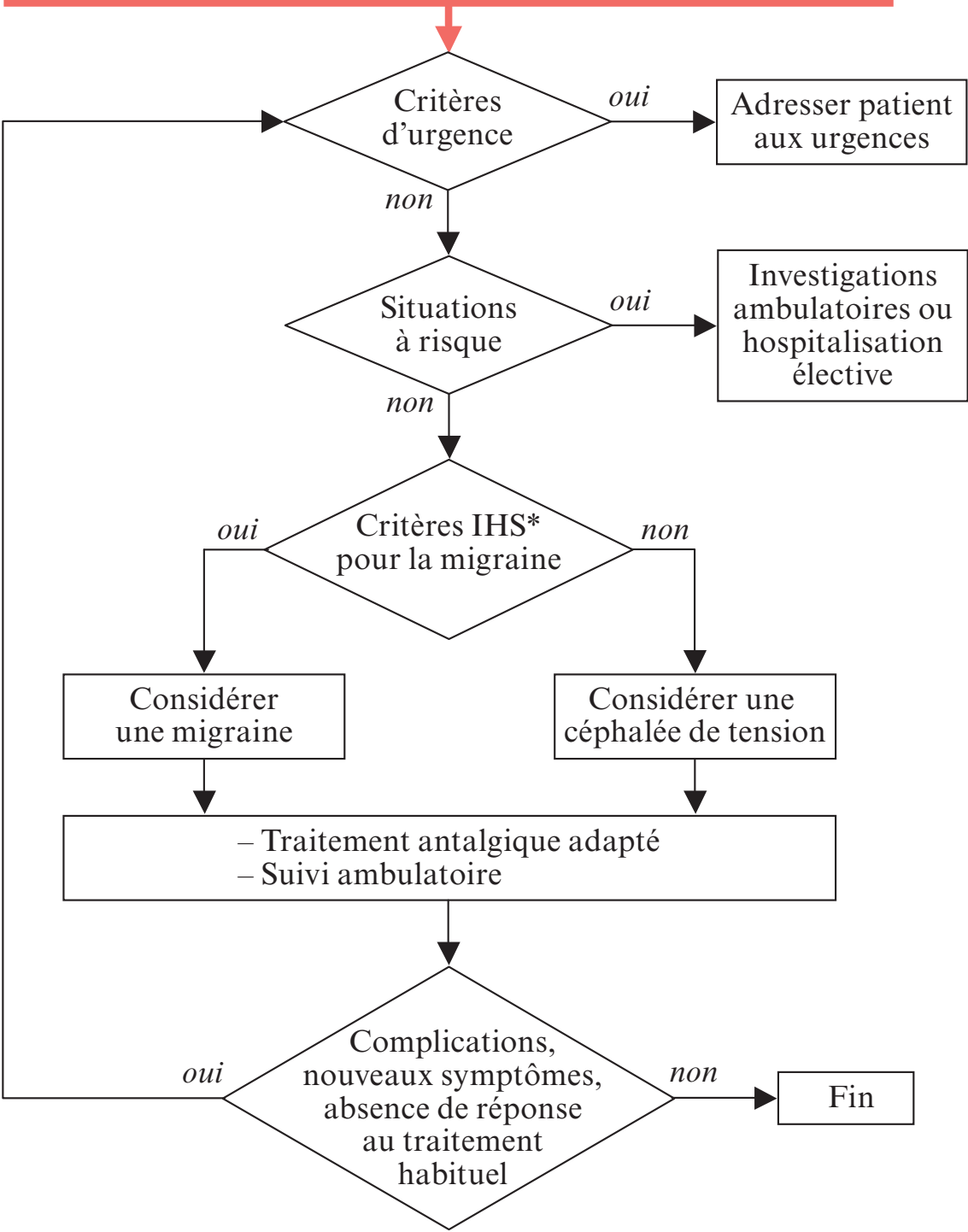
Tableau 1. Règle d'Ottawa pour une hémorragie sous-arachnoïdienne

Critères	
1. âge ≥ 40 ans	4. apparition de la douleur à l'effort
2. douleur ou raideur cervicale	5. céphalée en coup de tonnerre
3. perte de conscience objectivée	6. limitation de la flexion cervicale
La sensibilité est de ~98% et la spécificité de ~30% pour une hémorragie sous-arachnoïdienne dans les centres d'urgence.	

4. Diagnostic^{2-9,12,13}

Démarche diagnostique

Céphalées en médecine de premier recours



* IHS: *International Headache Society* (cf. Annexe en fin de chapitre)

39. Céphalée aiguë non traumatique

Examen clinique

- L'examen général doit comprendre:
 - les signes vitaux, en particulier la mesure de la tension artérielle;
 - la palpation du crâne et des artères temporales;
 - un examen plus détaillé si nécessaire: p. ex. auscultation cardio-pulmonaire, examen ORL, ostéo-articulaire (rachis, épaules).
- Au status neurologique, il faut évaluer la présence:
 - de signes méningés;
 - de signes de latéralisation;
 - d'anomalies à la station debout et/ou à la marche;
 - d'anomalies au fond d'œil.

N.B. Examen du **fond d'œil**: sa réalisation peut être limitée par l'expérience du praticien, la collaboration du patient, la présence d'une cataracte ou hémorragie intra-oculaire et par les conditions dans lesquelles il est effectué.

Examens paracliniques

- Les examens paracliniques: laboratoire, ponction lombaire et imagerie, dépendent du diagnostic différentiel considéré et sont à discuter en collaboration avec les spécialistes: neurologue, radiologue, urgentiste.

Examens complémentaires en fonction du type de céphalée

Imagerie

Contexte emblématique	Suspicion diagnostique	Imagerie
Céphalée en coup de tonnerre ou explosive	Hémorragie sous-arachnoïdienne	CT cérébral natif et injecté avec angio-CT en urgence
Douleur unilatérale, manipulation ou traumatisme cervical	Dissection carotido-vertébrale	CT cérébral natif et injecté avec angio-CT des vaisseaux du cou et cérébraux
Jeune femme, tabagisme, contraception orale, symptômes rarement aigus	Thrombose veineuse cérébrale	CT cérébral natif et injecté avec CT veineux cérébral
Personne jeune, état fébrile, raideur de nuque	Méningite	CT cérébral natif et injecté avant la PL si signes neurologiques focaux

Contexte emblématique	Suspicion diagnostique	Imagerie
Etat confusionnel, contexte infectieux	Encéphalite aiguë	CT cérébral natif et injecté avant PL (IRM peut être différée*)
Anamnèse de sinusite	Sinusite compliquée	CT selon avis du spécialiste
Femme enceinte ou post-partum	HTA, apoplexie pituitaire, pré-éclampsie, AVC, thrombose veineuse cérébrale, hémorragie sous-arachnoïdienne	Selon suspicion clinique et avis du spécialiste
Céphalées progressives, augmentées à la toux	Néoplasie	IRM ou CT cérébral natif et injecté selon disponibilité
Contexte septique, récente infection ORL	Abcès cérébral	IRM ou CT cérébral natif et injecté selon disponibilité
Patient immunodéprimé	Infection opportuniste	CT avant PL et IRM en différé*
Céphalée inhabituelle : patient souffrant d'alcoolisme	Hématome épidural	CT cérébral natif
Patient sous anti-coagulation, contexte post-traumatique	Hématome sous-dural	CT cérébral natif et injecté
Céphalées en position debout	Hypotension intracrânienne idiopathique	Selon avis du spécialiste
Jeune patient obèse	Hypertension intracrânienne	Selon avis du spécialiste
Patient hypertendu	Encéphalopathie HTA sans signes neurologiques focaux	Pas d'imagerie sauf si suspicion d'une autre pathologie
* L'examen peut être différé selon l'appréciation clinique de la situation par le spécialiste.		

N.B. En présence d’une céphalée en coup de tonnerre ou explosive, une imagerie cérébrale normale n’exclut pas une hémorragie sous-arachnoïdienne. En effet, lors d’une hémorragie sous-arachnoïdienne, 2% des CT cérébraux natifs seront normaux après le début de la céphalée, 10% après 1 jour, 50% après 5 jours. Une ponction lombaire doit donc être réalisée (voir ci-dessous).

39. Céphalée aiguë non traumatique

Laboratoire

- VS en cas de suspicion de maladie de Horton (artérite temporelle): céphalée nouvelle survenant après 50 ans et/ou douleurs des ceintures et/ou claudication de la mâchoire et/ou myalgie et/ou sensibilité temporelle.

N.B. Une VS basse n'exclut pas une artérite temporelle.

- En fonction de la clinique et de l'imagerie: crase, bilan inflammatoire, créatinine.

Ponction lombaire

Indications

- Suspicion d'hémorragie sous-arachnoïdienne et absence d'hémorragie à l'imagerie (céphalée de début brutal, la «pire des céphalées»)
- Suspicion de méningite ou méningo-encéphalite (fièvre, ménin-gisme, altération de la vigilance, trouble du comportement, état confusionnel, crise d'épilepsie)
- Suspicion de méningite carcinomateuse (néoplasie sous-jacente, signes d'hypertension intracrânienne, multinévrite crânienne)
- Autres selon le neurologue

Analyses

- Lors de suspicion d'**hémorragie sous-arachnoïdienne avec imagerie cérébrale normale**: examen du LCR routine (cellules, protéines totales, glycorachie), xanthochromie et/ou spectrophotométrie avec délai d'au moins 6 heures – mais idéalement 12 heures – entre le début des céphalées et la PL, ce qui augmente les chances de trouver une anomalie à la spectrophotométrie, mais avec le risque que le patient saigne à nouveau durant ce délai.
- Lors de suspicion de **méningite ou méningo-encéphalite**: examen du LCR routine, cultures et tests antigéniques et PCR spécifiques du LCR (recherche de germe en fonction de la suspicion clinique).

5. Prise en charge | Traitement¹⁴⁻¹⁶

N.B. Avant de débiter tout traitement médicamenteux, s’assurer qu’il n’existe pas de **contre-indication** : allergie, femme enceinte ou allaitant, interactions médicamenteuses !

A *Migraine*

- Traitement de fond non médicamenteux :
 - identifier et éviter les facteurs déclenchants ;
 - relaxation ;
 - hygiène de vie (activité physique, sommeil et alimentation) ;
 - gymnastique posturale, ergonomie à la place de travail.
- Traitement médicamenteux de la **crise** : **1 + 2 ± 3**

Exemples de médicaments	Dosage initial	Infos
1. Procinétiques utilisés pour la gastroparésie, souvent associée à une crise migraineuse		
 dompéridone	10 mg	Dos. max 4 ×/j
2. Antalgie		
 paracétamol	1 g	Dos. max 3 /j
 ibuprofène	400-600 mg	Dos. max 3 /j
3. Agonistes sérotoninergiques 5-HT1 (triptan)*		
 sumatriptan	25-50 mg PO	Dos. max/24 h 200 mg
	6 mg SC	Dos. max/24 h 12 mg
	20 mg spray nasal	Dos. max/24 h 40 mg
 almotriptan	12,5 mg	Dos max/24 h 25 mg
 eletriptan	40 mg	Dos. max/24 h 160 mg
 frovatriptan	2,5 mg	Dos. max/24 h 5 mg
 naratriptan	2,5 mg	Dos. max/24 h 5 mg
 rizatriptan	10 (5) mg	Dos. max/24 h 30 mg
 zolmitriptan	2,5 mg PO	Dose max/24 h 10 mg
	5 mg spray nasal	Dose max/24 h 10 mg
* ATTENTION: Ne pas combiner avec des dérivés d’ergotamine ou autres substances vasoactives. Contre-indication chez les patients coronariens, cérébrovasculaires ou avec une HTA non contrôlée. Réduire dose de rizatriptan si prise de propranolol.		

39. Céphalée aiguë non traumatique

N.B. En cas de crise particulièrement violente et importante, répercussion sur la qualité de vie: traitement parentéral ou triptan d'emblée.

N.B. Si le triptan choisi est insuffisant ou si sa tolérance est mauvaise, il vaut la peine de passer à une autre molécule de cette famille, tout en tenant compte du fait que toutes sont disponibles sous forme orale; par contre seuls le sumatriptan et le zolmitriptan existent sous forme de spray nasal. Il n'existe pas d'autre forme injectable que le sumatriptan.

— Traitement de fond ou **prophylactique**, 1^{er} choix:

Exemples de médicaments	Dosage initial	Infos
1. Bêtabloquants		
 métoprolol	100 mg/j	Dos. max 200 mg/j
 propranolol	40 mg/j 2-3 ×/j	Dos. max 160 mg/j

— Traitement de fond ou **prophylactique**, 2^e choix: en fonction des contre-indications et de l'efficacité propres à chaque patient, différentes options:

Exemples de médicaments	Dosage initial	Infos
2. Antiépileptiques		
 topiramate	25 mg/j	Augmenter de 25 mg/sem pour atteindre 100 mg en 2 doses par jour
3. Antidépresseurs tricycliques		
 amitriptyline	10-25 mg le soir	Augmenter si nécessaire de 10-25 mg/sem, max 150 mg/j

— Traitement de fond ou **prophylactique**, 3^e choix:

Médicament	Dosage initial	Infos
4. Anticorps monoclonaux		
 érénumab	70 mg SC 1 ×/mois	Ne peut être prescrit que par un neurologue

B**Céphalées de tension**

- Traitement de fond non médicamenteux :
 - relaxation ;
 - hygiène de vie (activité physique, sommeil et alimentation) ;
 - gymnastique posturale, ergonomie à la place de travail.
- Traitement de la **crise** : AINS et/ou analgésiques (*cf. Crise migraineuse*).
- **Prophylaxie** : antidépresseurs tricycliques (amitriptyline, *cf. Traitement de fond de la migraine*)
- D'une manière générale il est recommandé de se référer à la prise en charge du trouble fonctionnel (*cf. Chapitre 9 : Troubles fonctionnels*).

C**Céphalées en grappe**

- Traitement de la **crise** :
 - oxygène 100% : masque facial avec 10-12 l/min pdt 15 min.
 - agonistes sérotoninergiques 5-HT₁ en administration SC ou intranasale :
 -  sumatriptan 6 mg SC, au besoin répéter 6 mg SC (dosage max 12 mg/24 h)
 -  zolmitriptan 5 mg intranasal (dosage max 10 mg/24 h)
- Traitement **d'entretien/prophylactique** en collaboration avec un neurologue :
 - vérapamil, topiramate, corticoïdes, lithium, stimulation du grand nerf occipital

D**Céphalées par abus médicamenteux**

- A suspecter lors de céphalées chroniques avec consommation importante d'analgésiques, d'ergotamines ou d'agonistes sérotoninergiques 5-HT₁ (triptans)
- Traitement à discuter avec le neurologue
- Sevrage hospitalier selon la situation

6. Suivi | Complications | Pronostic

Quand référer le patient à un neurologue

- Présence d'un drapeau rouge qui reste inexpliqué
- Diagnostic incertain, migraine avec aura inhabituelle incluse
- Céphalées secondaires avec suspicion d'une atteinte neurologique sous-jacente
- Traitement d'une céphalée aiguë primaire insuffisamment efficace pour permettre un retour à domicile

Critères pour considérer une hospitalisation

- Céphalées primaires:
 - migraine avec aura inhabituelle non résolue;
 - état de mal migraineux.
- Céphalées secondaires: pathologie sous-jacente nécessitant une hospitalisation
- Céphalée primaire ou secondaire avec probabilité élevée d'impossibilité de retour à domicile dans les 24 heures

7. Message

- › En médecine de premier recours, la majorité des céphalées sont bénignes.
- › La recherche de drapeaux rouges doit être systématique afin d'identifier les patients nécessitant des investigations urgentes et/ou spécialisées.
- › Un examen neurologique doit toujours être effectué.
- › En cas de suspicion d'hémorragie sous-arachnoïdienne, un CT cérébral normal doit être suivi d'une ponction lombaire.

8. Annexe

Critères de l’IHS pour les céphalées primaires⁶

Migraine sans aura
A. Au moins 5 crises remplissant les critères B-D
B. Crise de migraine durant entre 4-72 heures (sans ttt ou ttt insuffisant)
C. La céphalée possède au moins 2 des caractéristiques suivantes: 1. Localisation unilatérale 2. Qualité pulsatile 3. Intensité modérée à sévère de la douleur 4. Aggravée par l’activité physique même légère (marche)
D. Pendant la céphalée, présence d’au moins un des signes/symptômes suivants: 1. Nausée et/ou vomissement 2. Photo- et phonophobie
E. Non attribuable à une autre affection
Migraine avec aura
A. Au moins 2 crises remplissant les critères B-C
B. Présence d’au moins un des symptômes suivants de l’aura complètement réversible: 1. Visuel 2. Sensitif 3. Élocution et/ou langage 4. Moteur 5. Tronc cérébral 6. Rétinien
C. Présence d’au moins trois des caractéristiques suivantes: 1. Apparition progressive en 5 minutes ou plus d’au moins un des symptômes de l’aura 2. Deux ou plus des symptômes de l’aura se succèdent 3. Chaque aura dure de 5 à 60 minutes 4. Un symptôme d’aura au moins est unilatéral 5. Une symptôme d’aura au moins est positif 6. L’aura est accompagnée, ou suivie dans les 60 minutes, par une céphalée
D. Non attribuable à une autre affection

39. Céphalée aiguë non traumatique

Céphalée de tension épisodique
A. Au moins 10 épisodes de céphalée en moyenne < 15 jours/mois remplissant les critères B-D
B. Durée de la céphalée: 30 minutes-7 jours
C. Douleurs avec ≥ 2 des caractéristiques suivantes: 1. Localisation bilatérale 2. Constrictives, pesantes, non pulsatiles 3. Intensité légère à modérée 4. Pas d'aggravation par l'activité physique simple telle marcher ou monter les escaliers
D. Présence de 2 des caractéristiques suivantes: 1. Pas de nausées, pas de vomissements 2. Photo- ou phonophobie (pas les deux)
E. Non attribuable à une autre affection
Céphalées en grappe (<i>cluster headache</i>)
A. Au moins 5 crises remplissant les critères B-D
B. Douleurs sévères ou très sévères orbitaires, supraorbitaires et/ou temporales unilatérales durant 15-180 minutes si non traitées
C. Présence d'un ou des deux critères suivants: 1. Au moins un des symptômes ou signes suivants ipsilatéraux à la céphalée: a) Injection conjonctivale et/ou larmoiement lacrimation b) Congestion nasale et/ou rhinorrhée c) Œdème palpébral d) Sudation du front et de la face e) Myosis et/ou ptosis 2. Impatience ou agitation
D. Fréquence variable entre 1×/2 jours à 8×/jour pour plus de la moitié des crises dans la période active
E. Non attribuable à une autre affection

9. Références bibliographiques | Liens

1. Martin V, Elkind A. Diagnosis and classification of primary headache disorders. Dans: Mishkin B, Solomon GD. Standards of care for headache diagnosis and treatment. Chicago: National Headache Foundation, 2004. p. 4-18.
2. Ceppi M, Willi C, Hugli O, Regli L, Cereda C, Maeder P, et al. Recommandations pratiques pour le diagnostic en urgence des céphalées aiguës non traumatiques. *Rev Med Suisse*. 2008; 4(167): 1741-6.
3. Sandor PS, Sturzenegger M, Gantenbein AR. Céphalées dites primitives: 1^{re} partie. *Forum Médical Suisse – Swiss Medical Forum*. 2012; 12(04): 72-7.
4. Gantenbein AR, Sandor PS, Sturzenegger M. Céphalées dites primitives: 2^e partie. *Forum Médical Suisse - Swiss Medical Forum*. 2012; 12(05): 87-92.
5. Morel P, Rutschmann O, Delemont C. Quand référer aux urgences un patient présentant une céphalée? *Rev Med Suisse*. 2010; 6(259): 1526-9.
6. Headache Classification Committee of the International Headache Society (HIS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. *Cephalalgia*. 2018; 38(1): 1-211.
7. Schankin C, Meier N, Streit S, Fischer U. Le patient céphalalgique au service des urgences: comment procéder? *Forum Médical Suisse – Swiss Medical Forum*. 2017; 17(19): 425-33.
8. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of patients presenting to the emergency department with acute headache. *Ann Emerg Med*. 2002; 39(1): 108-22.
9. Jordan JE, Expert Panel on Neurologic Imaging. Headache. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2007; 28(9): 1824-6.
10. Bellolio MF, Hess EP, Gilani WI, VanDyck TJ, Ostby SA, Schwarz JA, et al. External validation of the Ottawa subarachnoid hemorrhage clinical decision rule in patients with acute headache. *Am J Emerg Med*. 2015; 33(2): 244-9.
11. Perry JJ, Stiell IG, Sivilotti ML, Bullard MJ, Hohl CM, Sutherland J, et al. Clinical decision rules to rule out subarachnoid hemorrhage for acute headache. *Jama*. 2013; 310(12): 1248-55.
12. Moisset X, Mawet J, Guegan-Massardier E, Bozzolo E, Gilard V, Tollard E, et al. French Guidelines For the Emergency Management of Headaches. *Rev Neurol*. 2016; 172(6-7): 350-60.
13. De Luca GC, Bartleson JD. When and how to investigate the patient with headache. *Semin Neurol*. 2010; 30(2): 131-44.
14. Société suisse pour l'étude des céphalées. Céphalées et algies faciales: recommandations thérapeutiques avec algorithme décisionnel pour le médecin traitant [En ligne]. 10^e édition. Bâle: Société suisse pour l'étude des céphalées; 2019 [cité le 19 mars 2019]. Disponible: https://www.swissneuro.ch/download/Content_filebase/AttachmentDocument/SKG_Therapieempfehlungen_2018_FR_04_WEB.pdf
15. Davoine E, Kleinschmidt A. Migraine: des recommandations générales à la prise en charge pratique. *Rev Med Suisse*. 2016; 12(524): 1214-9.
16. Fontebasso M. Diagnosis, assessment and management of headache. *Prescriber*. 2016; 27(9): 35-45.